



PROTOCOLO — PRONTO-SOCORRO NATAL DIEGUES

Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi / SP • Secretaria Municipal de Saúde

Série de protocolos institucionais de urgência e emergência — uso interno da equipe médica

Protocolo 06 — Viroses agudas no PS: gastroenterite aguda, IVAS (resfriado, faringite, otite, sinusite), síndrome gripal / influenza / COVID-19 e tosse/sibilância viral / bronquiolite

Quando é vírus e quando não é; hidratação por planos A/B/C; critérios de antibiótico, antiviral e notificação; sinais de alarme e alta segura — adulto e criança; cenário: pronto-socorro sem UTI própria

Código	PS-ND-06	Versão	1.0 (minuta)
Elaboração	Felipe Ribeiro Toledo — Médico — CRM-SP 216.986	Data-base	setembro/2026
Aprovação (Diretor Clínico)	_____	Vigência	___/___/___
Aprovação (Coordenação PS)	_____	Revisão prevista	___/___/___

0. Escopo, premissas e fontes

As viroses respondem por 30-50% dos atendimentos do PS e são o maior campo de **iatrogenia por excesso**: antibiótico para faringite/otite/sinusite virais, exames e soro venoso para diarreia que se trata com SRO, corticoide e broncodilatador para bronquiolite, e — no outro extremo — a síndrome gripal que evolui para SRAG sem oseltamivir e sem notificação. Este protocolo organiza os quatro grupos clínicos pela mesma lógica: **reconhecer o padrão viral, identificar os poucos sinais que mudam a conduta, tratar sintomas com o mínimo eficaz e ensinar sinais de alarme**.

Fontes de ancoragem: Ministério da Saúde. *Manejo do paciente com diarreia* (cartaz/planos A, B, C) e *Guia de Vigilância em Saúde* (edição vigente) [MS-DIARREIA]; OMS/UNICEF. *Treatment of diarrhoea: a manual* (2005) e recomendação de SRO de baixa osmolaridade + zinco [OMS]; Sociedade Brasileira de Pediatria. *Diarreia aguda: diagnóstico e tratamento* (Guia Prático, 2017) [SBP-DA]; Shane AL, et al. IDSA guideline for infectious diarrhea. *Clin Infect Dis* 2017;65:e45 [IDSA-DIA 2017]; Ministério da Saúde. *Protocolo de tratamento de influenza* (edição vigente 2023/2024) e Nota Informativa sazonal [MS-INFLUENZA]; Uyeki TM, et al. IDSA influenza guideline. *Clin Infect Dis* 2019;68:e1; SBP/SBI — Síndrome gripal e COVID-19 (protocolos vigentes do MS) [MS-COVID]; Shulman ST, et al. IDSA guideline for group A streptococcal pharyngitis. *Clin Infect Dis* 2012;55:e86 [IDSA-FARINGITE]; Lieberthal AS, et al. AAP guideline: acute otitis media. *Pediatrics* 2013;131:e964 [AAP-OMA]; Rosenfeld RM, et al. Clinical practice guideline: adult sinusitis. *Otolaryngol Head Neck Surg* 2015 [AAO-HNS]; Ralston SL, et al. AAP guideline: bronchiolitis. *Pediatrics* 2014;134:e1474 [AAP-BQL] e SBP. *Diretrizes para o manejo da infecção causada pelo VSR* (2017) [SBP-VSR]; NICE NG9 (bronchiolitis, 2021).

Convenção de confiança: doses trazem a fonte; pediátricas sob dose lock. **[VERIFICAR]:** SRO de baixa osmolaridade e zinco em estoque, teste rápido de estreptococo/influenza/COVID/VSR, oseltamivir (dispensação), oxímetro pediátrico, espaçadores.

A. Gastroenterite aguda (diarreia aguda)

A1. Queixa

"Diarreia (≥ 3 evacuações amolecidas/líquidas em 24 h), vômitos, cólica, febre baixa", início súbito, contato com casos semelhantes, alimento suspeito, viagem; em criança: "não quer mamar", "está molinha", "urinou pouco", "olhos fundos". Duração < 14 dias = aguda (viral: rotavírus, norovírus, adenovírus, astrovírus — 70-80%); 14-30 dias = persistente; > 30 = crônica (fora do escopo).

A2. Clínica — o que muda a conduta

Achado	Significado / conduta
Grau de desidratação (Plano A/B/C)	Define o tratamento — ver A6
Sangue/muco nas fezes, febre alta, tenesmo (disenteria)	Bacteriana (<i>Shigella</i> , <i>Campylobacter</i> , <i>Salmonella</i> , <i>E. coli</i> êntero-invasiva) ou amebíase → coprocultura; antibiótico só nos casos de A7; não usar antidiarreico
Diarreia aquosa profusa "água de arroz", desidratação rápida, surto	Cólera (notificação imediata) — raro; toxinas
Vômitos predominantes, início 6–12 h após alimento, vários comensais	Intoxicação alimentar por toxina (<i>S. aureus</i> , <i>B. cereus</i>) — autolimitada
Antibiótico nas últimas 8 semanas, internação, idoso	<i>C. difficile</i> → toxina nas fezes; vancomicina VO
Diarreia + dor abdominal localizada, sinais peritoneais, distensão, sangramento intenso	Diferenciais cirúrgicos (apendicite, intussuscepção <2 anos, isquemia mesentérica, DII) — Protocolo 20
Imunossuprimido, HIV, desnutrição grave, <2 meses, diarreia >7 dias com piora	Investigar; internar/transferir

A3. Avaliação da desidratação [MS-DIARREIA; OMS; SBP-DA] — olhar, perguntar, examinar

Observe / examine	Sem desidratação (Plano A)	Desidratação (Plano B) — ≥2 sinais	Desidratação grave (Plano C) — ≥2 sinais, incluindo 1 destacado
Estado geral	Bem, alerta	Irritado, intranquilo	Letárgico, inconsciente, hipotônico
Olhos	Normais	Fundos	Muito fundos e secos
Lágrimas	Presentes	Ausentes	Ausentes
Boca e língua	Úmidas	Secas	Muito secas
Sede	Bebe normalmente	Sedento, bebe ávido	Bebe mal ou não consegue beber
Sinal da prega	Desaparece imediatamente	Desaparece lentamente	Desaparece muito lentamente (>2 s)
Pulso / TEC	Normal	Rápido, fraco / TEC <3 s	Muito fraco ou ausente / TEC >3 s
Perda de peso estimada	<3%	3–9%	≥10% (choque)

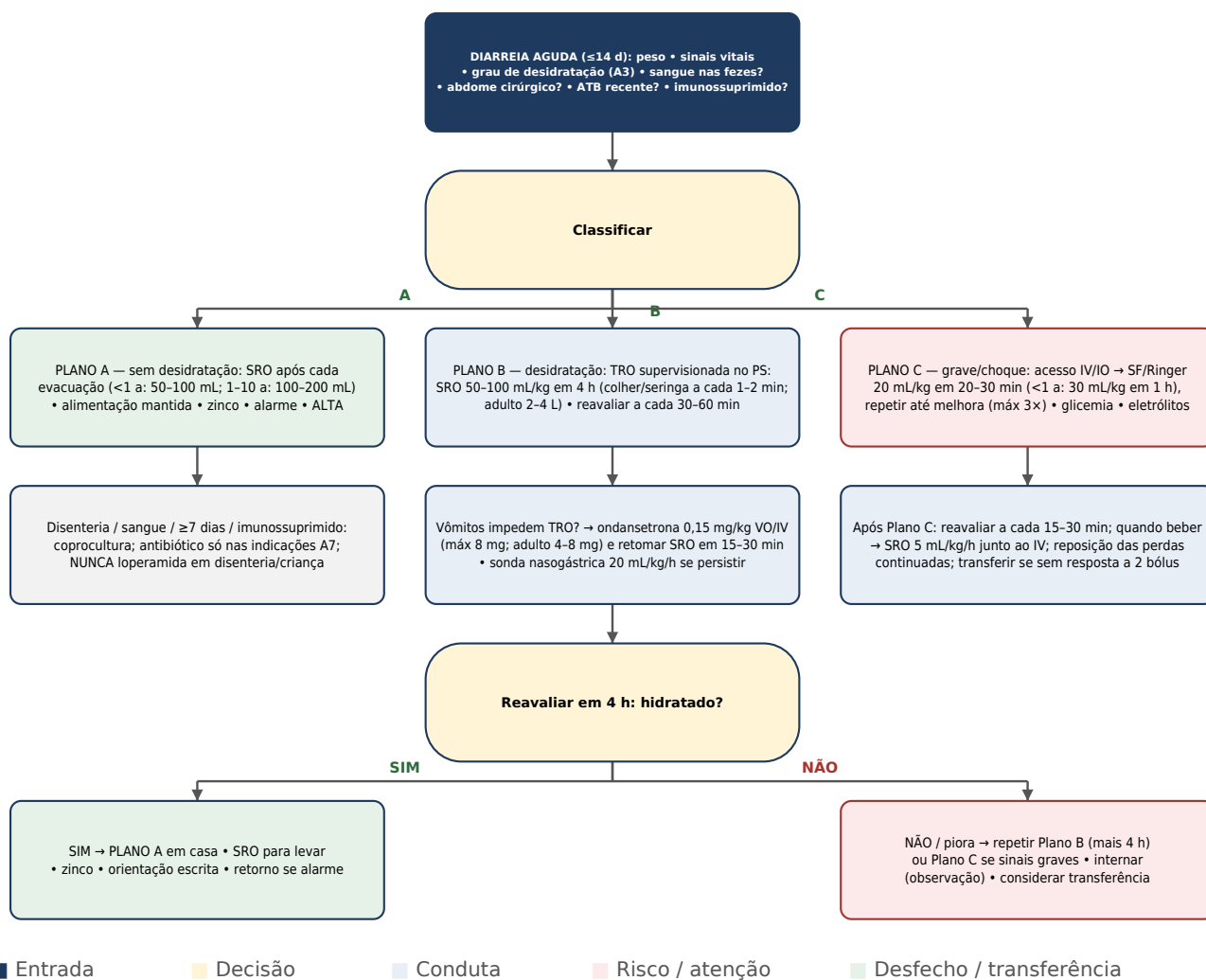
A4. Exame físico e propedêutica

- Peso (criança) — base de todos os cálculos; sinais vitais; sensorio; TEC; abdome (distensão, dor localizada, massas, visceromegalias); fezes (aspecto, sangue).
- Exames não são necessários** na diarreia aguda sem desidratação grave, sem sangue e sem sinais de gravidade (MS/SBP/IDSA). Indicar: eletrólitos/gasometria/glicemia/creatinina no Plano C, desidratação hipernatrêmica (irritabilidade, pele pastosa) ou hiponatrêmica, letargia desproporcional, lactente pequeno, diarreia prolongada; coprocultura na disenteria, surto, imunossuprimido, viagem; toxina de *C. difficile* se ATB recente; hemograma/PCR não decidem antibiótico.

A5. Fisiopatologia (resumo)

Vírus lesam os enterócitos das vilosidades (má absorção, diarreia osmótica) e, no rotavírus, a toxina NSP4 ativa secreção de cloro; bactérias enteroinvasivas causam inflamação e disenteria; toxinas (cólera, ETEC) ativam adenilato-ciclase (diarreia secretora). Em todas, o **cotransportador sódio-glicose (SGLT1) permanece íntegro** — base da terapia de reidratação oral: glicose + sódio na proporção da SRO arrasta água. A SRO de baixa osmolaridade (245 mOsm/L; Na 75, glicose 75) reduz vômitos e necessidade de soro IV; o zinco reduz a duração e a recorrência em crianças. A morte ocorre por hipovolemia (choque) e por distúrbio eletrolítico — não pelo germe.

A6. Fluxo — planos A, B e C [MS-DIARREIA; OMS; SBP-DA]



Plano C em detalhe (OMS/MS): <1 ano: 30 mL/kg em 1 h + 70 mL/kg em 5 h (total 100 mL/kg em 6 h); ≥1 ano: 30 mL/kg em 30 min + 70 mL/kg em 2,5 h (total 100 mL/kg em 3 h); adulto: 1-2 L rápido, depois conforme resposta. Em choque: bólus de 20 mL/kg em 20 min, repetir até 3× reavaliando (edema, hepatomegalia, estertores). Reavaliar a cada 15-30 min; se sem melhora após 2 bólus → sepse? cardiopatia? → transferir. Hipoglicemia frequente em lactente desnutrido: glicemia capilar sempre. Desidratação **hipernatrêmica** (Na >150): corrigir lentamente (≤0,5 mEq/L/h; ≤10-12 mEq/24 h) — preferir SRO; IV só com solução isotônica e reavaliação eletrolítica a cada 4 h.

A7. Tratamento farmacológico — o que fazer e o que não fazer [MS; SBP-DA; IDSA-DIA 2017]

Fármaco	Indicação e dose	Observações
SRO de baixa osmolaridade (Na 75 / glicose 75 / 245 mOsm)	Base de tudo; volumes por plano	Preparar com 1 L de água filtrada/fervida; validade 24 h; não adoçar; soro caseiro só na falta (1 colher-café de sal + 2 colheres-sopa de açúcar em 1 L)
Zinco	<6 meses: 10 mg/dia; ≥6 meses: 20 mg/dia, por 10–14 dias (criança)	Reduz duração e recorrência (OMS/MS) [VERIFICAR estoque]
Ondansetrona	0,15 mg/kg VO/IV, dose única (máx. 8 mg); adulto 4–8 mg	Reduz vômitos e necessidade de IV; não usar de rotina sem vômitos; QT; evitar <6 meses
Metoclopramida / prometazina / dimenidrinato	—	Evitar em criança (extrapiramidal, sedação); adulto: metoclopramida 10 mg se ondansetrona indisponível
Probióticos (<i>S. boulardii</i> , <i>L. rhamnosus</i> GG)	Opcional: 1 sachê/dia por 5–7 dias	Redução modesta da duração (~1 dia); evidência recente (2018–2022) menos favorável; não obrigatório
Racecadotril	Criança: 1,5 mg/kg 8/8 h por ≤7 dias; adulto 100 mg 8/8 h	Antissecretor; benefício modesto; opcional; não substitui SRO
Loperamida	Adulto sem febre/sangue: 4 mg + 2 mg após cada evacuação (máx. 16 mg/dia) por ≤2 dias	Contraindicada em criança <12 anos, disenteria, febre alta, suspeita de <i>C. difficile</i> /toxigênica (íleo, megacólon)
Antibiótico — indicações restritas	- Disenteria com toxemia/febre alta/sepsse ou imunossuprimido: azitromicina 10 mg/kg/dia 3 dias (adulto 500 mg/dia 3 d) ou ciprofloxacino 500 mg 12/12 h 3 d (adulto) <i>Shigella</i> confirmada; cólera (azitromicina 1 g dose única / doxiciclina); amebíase (metronidazol 35–50 mg/kg/dia 8/8 h 7–10 d; adulto 500–750 mg 8/8 h); giardíase (metronidazol 15 mg/kg/dia 5–7 d); <i>C. difficile</i> (vancomicina VO 125 mg 6/6 h 10 d) - Diarreia do viajante moderada/grave (azitromicina)	Não usar em diarreia aquosa viral, <i>Salmonella</i> não tifoide sem risco (prolonga excreção), <i>E. coli</i> O157/SHU (piora). Coprocultura antes
Antiparasitário empírico	—	Não na aguda; tratar por exame de fezes
Dieta	Manter/retomar precocemente (após 4 h de TRO); aleitamento contínuo; evitar sucos/refrigerantes (osmóticos); dieta habitual sem restrição de lactose (exceto intolerância evidente)	"Jejum para descansar o intestino" é errado

A8. Alta, internação e notificação

- **Internar/transferir:** Plano C sem resposta, choque, alteração de sensório, distúrbio eletrolítico grave, íleo/distensão, sinais cirúrgicos, <2 meses com desidratação, desnutrição grave, imunossuprimido, falha da TRO (vômitos incoercíveis apesar de ondansetrona e SNG), sem cuidador capaz.
- **Alta:** hidratado, tolerando SRO/alimento, cuidador orientado por escrito (volumes, sinais de alarme: sangue, vômitos persistentes, sonolência, olhos fundos, urina escassa por >6–8 h, febre alta, piora), SRO e zinco dispensados, retorno em 24–48 h se piora.
- **Notificação:** surtos de doença diarreica aguda (≥2 casos vinculados) e casos de cólera, febre tifoide, SHU — vigilância municipal (MDDA — monitorização semanal de casos de diarreia é rotina do serviço).
- Prevenção: rotavírus (PNI), lavagem de mãos, água tratada; afastar de creche até 24–48 h sem sintomas.

B. Infecções de vias aéreas superiores (IVAS)

Resfriado comum, faringotonsilite, otite média aguda, rinossinusite aguda e laringite viral (crupe) são **virais na grande maioria**. A pergunta única do PS é: **há um critério objetivo para antibiótico?** Se não, tratam-se sintomas e ensina-se o retorno.

Síndrome	Quadro típico (viral)	Quando pensar em bacteriano / o que muda	Tratamento
Resfriado comum / rinofaringite	Coriza, obstrução, espirros, tosse, dor de garganta leve, febre baixa; 7-10 dias; secreção amarela/verde é normal	Nunca é indicação de ATB; complicações: otite, sinusite (ver abaixo)	Lavagem nasal com SF 0,9%, analgésico/antitérmico, hidratação, mel (>1 ano), elevação da cabeça. Evitar descongestionante sistêmico e antitussígeno em <6 anos; anti-histamínico não ajuda
Faringotonsilite	Tosse, coriza, rouquidão, conjuntivite, úlceras orais, diarreia → viral (70-85%)	Estreptococo do grupo A (15-30% em 5-15 anos; 5-15% adulto): Centor/Mclsaac — febre >38, exsudato tonsilar, adenopatia cervical anterior dolorosa, ausência de tosse (+1 se 3-14 anos; -1 se ≥45). 0-1: sem ATB; 2-3: teste rápido/cultura; ≥4: tratar (ou testar). Mononucleose: esplenomegalia, adenopatia posterior, linfocitose atípica — não dar amoxicilina (rash)	Penicilina benzatina 1,2 milhão UI IM dose única (<27 kg: 600.000 UI) ou amoxicilina 50 mg/kg/dia (máx. 1 g/dia) por 10 dias (adulto 500 mg 12/12 h ou 1 g/dia); alergia: azitromicina 12 mg/kg/dia 5 d (adulto 500 mg/dia 5 d) ou cefalexina; analgesia; corticoide dose única (dexametasona 0,6 mg/kg, máx. 10 mg) só para dor intensa/obstrução
Otite média aguda	Após resfriado; otalgia, febre, irritabilidade; otoscopia: membrana abaulada, hiperemia, opaca	Viral/autolimitada em 60-80% em 24-72 h. ATB imediato: <6 meses; 6-24 meses bilateral ou com otorreia; qualquer idade com otalgia intensa/>48 h/febre ≥39/toxemia. Observação 48-72 h com analgesia (AAP): ≥6 meses unilateral leve, ≥2 anos leve, com retorno garantido	Amoxicilina 80-90 mg/kg/dia 12/12 h (adulto 500 mg 8/8 h ou 875 mg 12/12 h) por 10 dias (<2 a), 7 dias (2-5 a), 5-7 dias (≥6 a); amoxicilina-clavulanato se ATB ≤30 d, conjuntivite associada (<i>H. influenzae</i>) ou falha em 48-72 h; alergia: cefuroxima/azitromicina; analgesia (dipirona/paracetamol/ibuprofeno); sem descongestionante/anti-histamínico
Rinossinusite aguda	Congestão, secreção, dor facial, hiposmia por <10 dias — viral	Bacteriana (0,5-2%): sintomas ≥10 dias sem melhora , ou piora após melhora inicial ("dupla piora"), ou início grave (febre ≥39 + secreção purulenta ≥3-4 dias). RX/TC não indicados de rotina. Alarme: edema/eritema periorbitário, proptose, diplopia, cefaleia intensa, rigidez de nuca, alteração de consciência → complicação orbitária/intracraniana → TC e transferência	Lavagem nasal, corticoide nasal, analgesia; se critério bacteriano: amoxicilina 500 mg 8/8 h (ou amoxicilina-clavulanato 875/125 12/12 h) por 5-7 dias (criança 45-90 mg/kg/dia 10 dias); alergia: doxiciclina (adulto) / cefuroxima; quinolona não é 1ª linha

Síndrome	Quadro típico (viral)	Quando pensar em bacteriano / o que muda	Tratamento
Laringite viral / crupe (6 m-6 a)	Tosse "de cachorro", rouquidão, estridor inspiratório noturno, febre baixa; parainfluenza	Estridor em repouso, tiragem, agitação/sonolência, cianose = grave (escore de Westley); diferenciais: epigloteite (toxemia, sialorreia, sem tosse — não examinar a garganta), corpo estranho, abscesso retrofaríngeo, traqueíte bacteriana	Dexametasona 0,15-0,6 mg/kg VO/IM dose única (máx. 10-16 mg) a todos; estridor em repouso: adrenalina nebulizada 0,5 mL/kg (1 mg/mL), máx. 5 mL , observar 2-4 h (rebote); O ₂ se SpO ₂ <92%; sem ATB; grave/sem resposta → transferir com via aérea preparada
Conjuntivite viral	Bilateral, hiperemia, secreção aquosa, adenopatia pré-auricular; adenovírus	Purulenta espessa → bacteriana (tobramicina/cloranfenicol colírio); dor intensa, fotofobia, baixa visão, herpes → oftalmologia	Compressas frias, lubrificante, higiene; afastar da escola

Sinais de alarme comuns a todas as IVAS: dificuldade respiratória, estridor em repouso, sialorreia/incapacidade de deglutir, trismo/assimetria de amígdala (abscesso peritonsilar — drenagem), rigidez de nuca, edema periorbitário, febre >5 dias, toxemia, desidratação, lactente <3 meses com febre (protocolo de febre sem foco — investigar).

C. Síndrome gripal, influenza e COVID-19

C1. Definições de vigilância [MS-INFLUENZA; Guia de Vigilância]

Termo	Definição	Conduta
Síndrome gripal (SG)	Febre (mesmo referida) de início súbito + tosse ou dor de garganta + ≥1 de: cefaleia, mialgia, artralgia; em <2 anos: febre súbita + sintomas respiratórios (tosse, coriza, obstrução) sem outro diagnóstico	Sintomáticos; oseltamivir nos grupos de risco/graves (C3); teste conforme sazonalidade; isolamento domiciliar
SRAG	SG + dispneia/desconforto respiratório ou pressão/dor torácica persistente ou SpO ₂ <95% em ar ambiente ou cianose; criança: tiragem, batimento de asa nasal, cianose, desidratação, inapetência	Internar , oseltamivir imediato, coleta de swab (influenza/SARS-CoV-2/VSR), notificação imediata no SIVEP-Gripe ; RX; avaliar pneumonia/seps (Protocolos 10/05)
Grupos de risco para complicação (indicam oseltamivir na SG mesmo sem gravidade)	Gestante (qualquer IG) e puérpera até 2 semanas; <5 anos (esp. <2); ≥60 anos; pneumopatia (asma, DPOC), cardiopatia, DRC, hepatopatia, DM, doença neurológica/neuromuscular, imunossupressão (HIV, quimioterapia, transplante, corticoide), obesidade (IMC ≥40), hemoglobinopatia, trissomias, indígenas, ILPI	Oseltamivir em ≤48 h do início (iniciar mesmo depois se hospitalizado/grave); retorno em 48 h

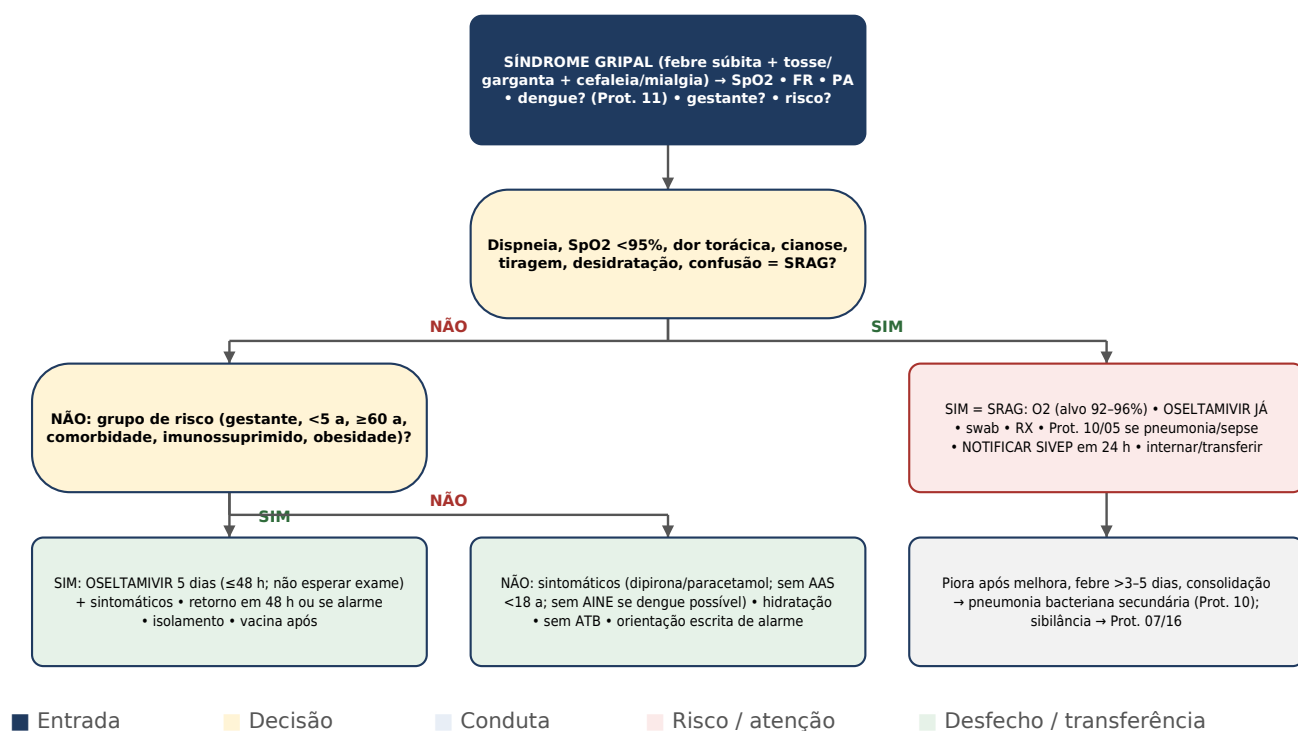
C2. Clínica e diferenciais

- Influenza: início abrupto, febre alta, mialgia intensa, cefaleia, prostração; tosse seca; 3-7 dias (tosse até 2 semanas). Complicações: pneumonia viral primária ou bacteriana secundária (pneumococo, *S. aureus* — piora após melhora), miocardite, encefalite, exacerbação de asma/DPOC/IC, síndrome de Reye (AAS em criança).
- COVID-19: anosmia/ageusia, fadiga, sintomas GI; hipoxemia silenciosa — medir SpO₂ em todo caso; dispneia entre o 5º e o 10º dia.
- Diferenciais: **dengue** (Protocolo 11 — não dar AINE/AAS na dúvida), COVID, VSR, adenovírus, pneumonia bacteriana, meningococcemia (petéquias), leptospirose, malária (viagem), seps de outro foco.
- Sinais de alarme para retorno imediato: dispneia, SpO₂ <95%, dor torácica, confusão, febre >3 dias ou que retorna, hemoptise, hipotensão, oligúria, criança que não bebe/mama, sonolência.

C3. Tratamento [MS-INFLUENZA; MS-COVID; IDSA 2019]

Medida	Adulto	Criança	Observações
Oseltamivir	75 mg VO 12/12 h por 5 dias	≤15 kg: 30 mg 12/12 h; 15-23 kg: 45 mg; 23-40 kg: 60 mg; >40 kg: 75 mg; <1 ano: 3 mg/kg/dose 12/12 h (2 mg/kg em <3 meses)	Iniciar em ≤48 h na SG de risco; sempre na SRAG/internado independentemente do tempo; ClCr 10-30: 75 mg 1x/dia; gestante: mesma dose; dispensação pelo PS/UBS [VERIFICAR]; não aguardar resultado de exame
Zanamivir inalatório	10 mg 12/12 h 5 dias	≥7 anos	Alternativa se intolerância; não em asma/DPOC
Sintomáticos	Dipirona 500-1.000 mg ou paracetamol 500-1.000 mg até 6/6 h; hidratação; repouso	Dipirona 10-15 mg/kg ou paracetamol 10-15 mg/kg até 6/6 h	Sem AAS em <18 anos (Reye); sem AINE se dengue possível; sem antibiótico sem pneumonia/otite/sinusite bacteriana
COVID-19 leve (ambulatorial)	Sintomáticos; nirmatrelvir-ritonavir 300/100 mg 12/12 h 5 dias em ≤5 dias nos grupos de risco, se disponível no SUS e sem interação	Sintomáticos	Sem corticoide, sem anticoagulante, sem ATB na doença leve; isolamento; dexametasona 6 mg/dia só se hipoxemia (internado)
Quimioprofilaxia (oseltamivir 75 mg/dia 10 dias)	Contactante de alto risco não vacinado, surto em ILPI, profissional exposto sem EPI	1x/dia por peso	Conforme nota da vigilância
Vacinação	Influenza anual; COVID conforme calendário; pneumococo nos grupos	PNI	Orientar na alta

C4. Fluxo de decisão — síndrome gripal



D. Tosse e sibilância viral do lactente / bronquiolite viral aguda

D1. Definição e clínica [AAP-BQL 2014; SBP-VSR 2017; NICE NG9]

Bronquiolite: primeiro episódio de sibilância/esforço respiratório em lactente <2 anos (pico 2-6 meses), precedido por 1-3 dias de coriza, tosse e febre baixa, com taquipneia, tiragem, crepitações e/ou sibilos difusos; VSR em 60-80% (sazonal: março-agosto), rinovírus, metapneumovírus. Piora até o 3º-5º dia, resolve em 1-2 semanas (tosse até 3-4). **Diagnóstico clínico — não pedir RX, hemograma, PCR ou painel viral de rotina.** Sibilância recorrente (≥2 episódios), atopia, resposta clara a broncodilatador → considerar asma do pré-escolar (Protocolo 07).

Gravidade	Leve	Moderada	Grave
Alimentação	Normal / >75%	50-75%	<50%; incapaz
FR	<50/min	50-70	>70 ou apneia
Tiragem	Ausente/leve	Moderada	Grave; gemência; batimento de asa nasal; balanço da cabeça
SpO ₂ (ar ambiente)	≥92-94%	90-92%	<90%; cianose
Estado geral	Alerta	Irritável	Letárgico; exausto

Fatores de risco para gravidade: <3 meses (esp. <6 semanas — apneia), prematuridade <32-35 semanas, cardiopatia congênita, displasia broncopulmonar, imunodeficiência, doença neuromuscular, desnutrição, tabagismo domiciliar, falta de suporte. **Diferenciais:** pneumonia bacteriana (febre alta, consolidação, toxemia), coqueluche (tosse paroxística, apneia, cianose; <6 meses — internar, azitromicina), asma, aspiração/corpo estranho, IC, refluxo com aspiração, laringomalácia (estridor).

D2. Tratamento — o que funciona e o que não funciona [AAP 2014; SBP 2017; NICE 2021]

Medida	Recomendação	Observações
Suporte: desobstrução nasal (SF 0,9% + aspiração suave), alimentação fracionada , cabeceira elevada, hidratação	Base do tratamento	Aspiração profunda de rotina não recomendada; sonda nasogástrica/IV se <50% da ingesta
Oxigênio	Se SpO ₂ < 90% (AAP) / <92% (NICE/SBP) persistente; alvo ≥90–92%	Oximetria contínua só nos graves (quedas transitórias no sono são normais e prolongam internação); cateter nasal 1–2 L/min; alto fluxo nasal (1–2 L/kg/min) se falha do O ₂ convencional — reduz IOT [VERIFICAR]
Broncodilatador (salbutamol)	Não recomendado de rotina (AAP/NICE: não usar; SBP: teste terapêutico único aceitável em >6 meses com sibilância predominante/atopia — manter só se resposta objetiva)	Não altera internação nem duração; taquicardia; teste com salbutamol 2–4 jatos + espaçador e reavaliar em 20–30 min
Adrenalina nebulizada	Não de rotina; opção de resgate no PS em moderada/grave (0,5 mL/kg de 1 mg/mL, máx. 3–5 mL) com observação	Efeito transitório; não muda internação
Solução salina hipertônica 3% nebulizada	Não no PS; opcional em internados (reduz internação em ~1 dia em algumas revisões)	Evidência inconsistente
Corticoide (sistêmico ou inalado)	Não usar (sem benefício; AAP/NICE/SBP)	Exceção: asma do pré-escolar claramente estabelecida
Antibiótico	Não usar sem evidência de infecção bacteriana (otite, pneumonia com consolidação, sepse, ITU no lactente febril <3 meses)	Febre + bronquiolite em <3 meses: investigar ITU (urina); hemocultura/PL só se toxemia
Fisioterapia respiratória, antitussígeno, descongestionante, anti-histamínico, xarope	Não usar	—
Antitérmico	Dipirona/paracetamol se desconforto	—

D3. Decisão: alta × observação × internação/transferência

Alta (todos)	Internar (qualquer) / Transferir se sem pediatria-O ₂ -monitor no PS
- SpO₂ ≥92–94% em ar ambiente sustentada (inclusive após mamada e sono no PS) - FR <60, sem tiragem importante - Ingesta ≥75% do habitual; hidratado >3 meses (ou >6 semanas sem fator de risco), sem apneia - Cuidador capaz, orientado (lavagem nasal, alimentação fracionada, sinais de alarme), acesso ao serviço; retorno em 24–48 h	- SpO₂ <90–92% persistente ou necessidade de O₂ - FR >70, tiragem grave, gemência, apneia, cianose - Ingesta <50% / desidratação <6 semanas–3 meses, prematuro, cardiopata, DBP, imunodeficiente - Letargia, exaustão; piora rápida (dia 2–4 da doença) - Falha do cuidado domiciliar / distância UTI pediátrica: apneia recorrente, SpO₂ <90% com O₂, hipercapnia, exaustão, necessidade de alto fluxo/CPAP/IOT

Palivizumabe/nirsevimabe (profilaxia de VSR) e vacina materna de VSR: orientar prematuros/cardiopatas e gestantes conforme o calendário do PNI/CRIE — não é medida do PS.

8. Transferência, notificação e indicadores

8.1 Transporte e documentação

- Conforme gravidade (Plano C/SRAG/bronquiolite grave: USA com O₂, monitor, acesso e infusão em curso); isolamento respiratório (máscara cirúrgica) para SG/SRAG/COVID; precaução de contato para diarreia.
- Relatório: síndrome, grau de desidratação/gravidade respiratória, SpO₂, volumes infundidos e resposta, oseltamivir/antibiótico (dose/hora), exames e swab colhidos (informar notificação), peso, comorbidades, vacinação.
- Regulação: CROSS-SP / Central de Regulação. Referência: adulto → **Hospital Municipal Tabajara Ramos (Mogi Guaçu) — casos clínicos, UTI e hemodinâmica**; pediatria → **Santa Casa de Mogi Guaçu — casos cirúrgicos, ginecológicos/obstétricos e pediatria** (rede pactuada em 04/09/2026).

8.2 Notificações

- **SRAG**: imediata (24 h), SIVEP-Gripe, com swab. **SG**: em unidade sentinela / conforme orientação da vigilância (e-SUS Notifica para COVID).
- Surto de diarreia (≥2 casos vinculados), cólera, febre tifoide, SHU, rotavírus em <5 anos internados (vigilância sentinela) — vigilância municipal; MDDA semanal.
- Coqueluche, sarampo/rubéola (febre + exantema — Protocolo 11 para diferenciais), meningite — imediata.

8.3 Indicadores de qualidade (auditoria mensal)

Indicador	Meta
% de diarreia aguda com grau de desidratação (plano) documentado e SRO iniciada no PS	≥95%
% de diarreia sem desidratação grave que recebeu soro IV (evento)	Registrar; reduzir
% de antibiótico em diarreia aquosa, resfriado, faringite com Centor ≤1, OMA sem critério, sinusite <10 dias, bronquiolite (eventos sentinela)	0
% de faringite tratada com penicilina benzatina/amoxicilina (não macrolídeo sem alergia)	≥90%
% de SG em grupo de risco com oseltamivir em ≤48 h; % de SRAG com oseltamivir e notificação em 24 h	≥90% / 100%
% de SG com SpO ₂ registrada	100%
% de bronquiolite com broncodilatador/corticoide/RX de rotina (eventos)	Registrar; reduzir
% de altas com orientação escrita de sinais de alarme	≥90%
Retorno em 48-72 h por piora; internação após alta	Registrar; tendência de queda

9. Divergências entre fontes e itens a verificar antes da aprovação

Tema	Posição declarada
Plano C — volumes	OMS/MS: 100 mL/kg em 3-6 h por faixa etária; PALS/SBP: bólus 20 mL/kg repetidos. Adotados ambos (bólus no choque; esquema OMS na desidratação grave sem choque)
Broncodilatador na bronquiolite	AAP/NICE: não usar; SBP 2017: teste terapêutico em casos selecionados. Adotado: não de rotina; teste único em >6 meses com sibilância predominante e retirada se sem resposta
Limiar de O ₂ na bronquiolite	AAP: <90%; NICE/SBP: <92%. Adotado 90-92% com preferência por 92% em <3 meses/risco
Probióticos e racecadotril	Recomendações de sociedades (ESPGHAN) × ensaios recentes negativos (Schnadower 2018). Opcionais, nunca substituem SRO
Duração da amoxicilina na OMA	AAP: 10 dias <2 anos, 7 dias 2-5, 5-7 dias ≥6; alguns protocolos: 10 dias para todos. Adotada a AAP
Faringite — teste rápido	IDSA: testar Centor ≥2 antes de tratar; sem teste no PS, tratar Centor ≥4 (ou ≥3 em surto/criança) [VERIFICAR teste rápido]
Oseltamivir após 48 h	MS/IDSA: iniciar em internados/graves mesmo tardio. Adotado
Zinco, SRO 245 mOsm, teste rápido influenza/COVID/VSR, alto fluxo	Estoque/disponibilidade [VERIFICAR]
Doses pediátricas	Sujeitas ao dose lock institucional — conferir com o Protocolo de Pediatria

10. Referências

- Brasil. Ministério da Saúde. Manejo do paciente com diarreia (planos A, B, C); Guia de Vigilância em Saúde (doenças diarreicas agudas, influenza, SRAG), edição vigente. WHO/UNICEF. The treatment of diarrhoea: a manual for physicians and other senior health workers. 4th rev. Geneva, 2005; WHO/UNICEF joint statement: clinical management of acute diarrhoea (ORS + zinc), 2004.
- Sociedade Brasileira de Pediatria. Diarreia aguda: diagnóstico e tratamento (Guia Prático de Atualização, 2017). Shane AL, Mody RK, Crump JA, et al. 2017 IDSA clinical practice guidelines for the diagnosis and management of infectious diarrhea. Clin Infect Dis 2017;65(12):e45-e80. Schnadower D, et al. Lactobacillus rhamnosus GG versus placebo for acute gastroenteritis in children. N Engl J Med 2018;379:2002-2014.
- Brasil. Ministério da Saúde. Protocolo de tratamento de influenza (edição vigente) e notas informativas sazonais; Diretrizes para diagnóstico e tratamento da COVID-19 (edição vigente). Uyeki TM, et al. IDSA clinical practice guidelines: seasonal influenza. Clin Infect Dis 2019;68(6):e1-e47.
- Shulman ST, et al. Clinical practice guideline for the diagnosis and management of group A streptococcal pharyngitis: 2012 update by the IDSA. Clin Infect Dis 2012;55(10):e86-e102. Lieberthal AS, et al. The diagnosis and management of acute otitis media. Pediatrics 2013;131(3):e964-e999. Rosenfeld RM, et al. Clinical practice guideline (update): adult sinusitis. Otolaryngol Head Neck Surg 2015;152(2 Suppl):S1-S39. Bjornson CL, Johnson DW. Croup in children. CMAJ 2013;185:1317.
- Ralston SL, et al. Clinical practice guideline: the diagnosis, management, and prevention of bronchiolitis. Pediatrics 2014;134(5):e1474-e1502. Sociedade Brasileira de Pediatria. Diretrizes para o manejo da infecção causada pelo vírus sincicial respiratório, 2017. NICE. Bronchiolitis in children: diagnosis and management (NG9), 2015/2021.
- Velasco IT, et al. (eds.). Medicina de Emergência: abordagem prática — HC-FMUSP. Manole, edição vigente — capítulos de diarreia aguda e infecções respiratórias (página não conferida).

Felipe Ribeiro Toledo — Médico — CRM-SP 216.986

Responsável técnico pela elaboração